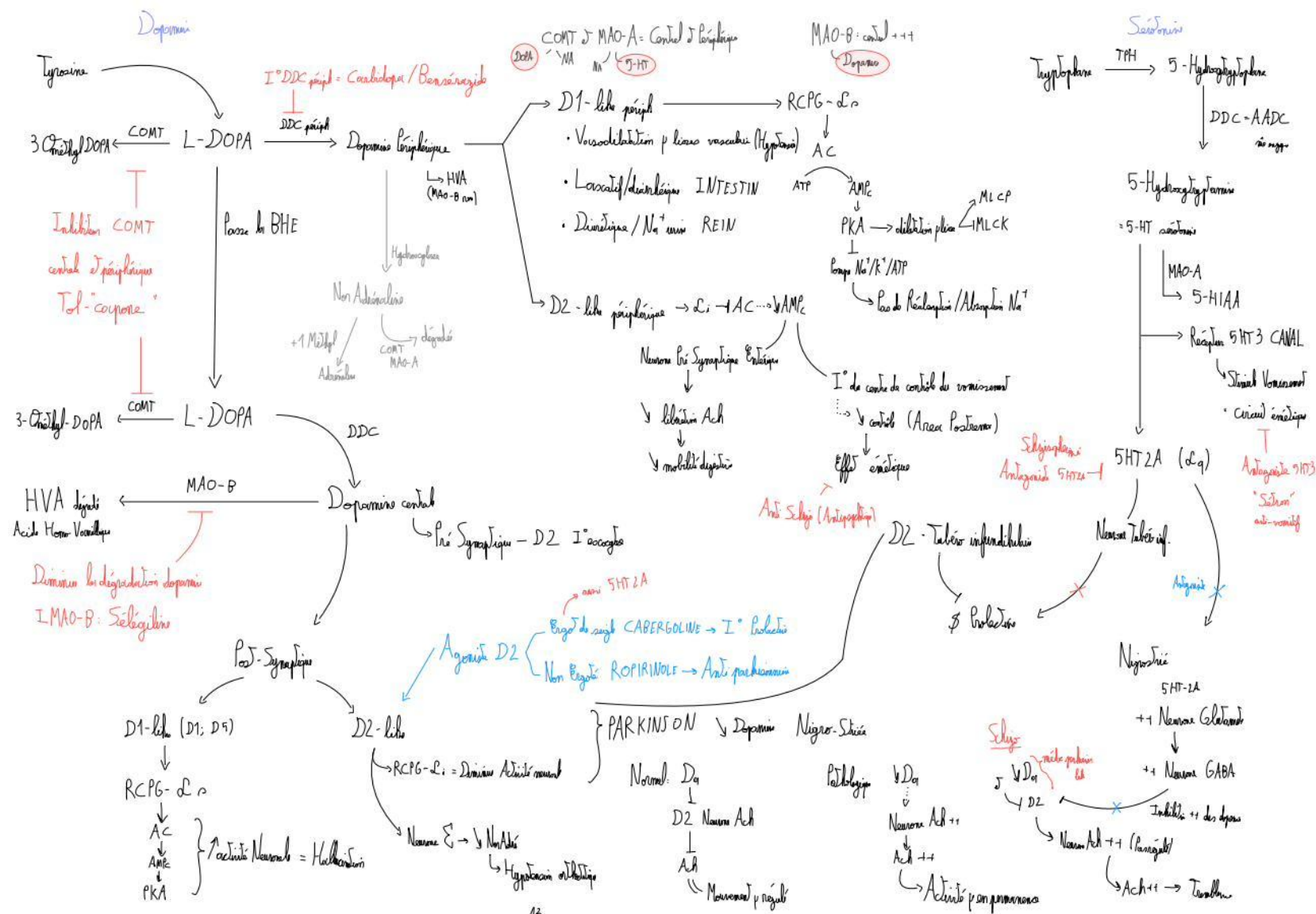




Parkinson = dégénérescence des neurones dopaminergiques von Nigro-Stria

- Akinesie
- Hypertonie
- Tremblement

Traitement Non Médicamenteux



Médicaments

chirurgie?

I° Hyperactivité cholinergique = Anticholinergiques $\rightarrow$ $\downarrow$ ACh $\rightarrow$ contrôle
MAIS Pt S° Anticholinergique

Remplacement activité dopaminergique

L-DOPA (Levodopa)

+ Inhibition DDC pré-synaptique $\rightarrow$ évite les EI (commissuraux) $\rightarrow$ économise DOPA

+ Dopamine

Benzazepine + L-DOPA = MODOPAR

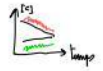
Carbidopa + L-DOPA = SINEMET

I. DDC

} Forme disponible ou propre

PB = EI, donc on cause = fluctuation

+ $\downarrow$ fonction thésaurique



La dose de mal (3:5cm) $\rightarrow$ l'effet efficace

Agoniste D2 + Dopamine effect

• IMAO $\rightarrow$ évite dégradation dopamine
• COMT

Neuroleptiques (Anti psychotiques)

S° malin: hypertonie + hypotension + pt cardiovasc

$\rightarrow$ Anti immédiat

EI long terme irréversible = dyskinésie tardive

dopamine = STOP ACh

Neuroleptique: $\downarrow$ dopamine = $\uparrow$ ACh = trouble moteur (dyskinésie)

Antidote: Trihexyphényldole (Anti cholinergique)

Naloxone = antidote morphine